

담도암 진단 첫 30일

위치 · 담도배액 · 유전자검사 · 전신치료 정리

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 09

MINI 무료 배포판 · Instagram 구독자용 · 2026년 10월 개정 2판

담도암은 ‘어디에 생겼는지’와 ‘담즙이 잘 흐르는지’가 첫 30일을 좌우합니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Biliary Tract Cancers, Version 1.2026 외 국내 자료(본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 MINI판에 대하여

이 MINI판은 진단 후 첫 30일 동안 **안전하게 판단하는 데 꼭 필요한 내용만** 담았습니다. 응급 신호, 진단 직후 할 일, 병리·병기의 핵심, 치료 흐름, 진료실 질문, 한 장 요약은 완전판과 같습니다. 30일 일자별 실행 로드맵, 치료별 준비·회복 가이드, 한국 제도·보험 서류 안내, 마음 돌보기와 보호자 가이드, 워크북은 완전판에 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 담도암의 위치

30초 요약

- **담도암**은 담즙이 흐르는 길 전체에 생기는 암을 말하며, 위치에 따라 **간내 담관암 / 간문부 담관암 / 원위부 담관암 / 담낭암**으로 나눕니다. 위치마다 수술 방법이 다릅니다.
- 완치를 목표로 하는 가장 중요한 치료는 가능한 경우 **암을 남김없이 떼어내는 완전 절제(R0)**입니다.
- 황달이 있으면 **담도배액**(스텐트·배액관)이 먼저일 수 있습니다.
- 수술이 어렵다면 **1차 치료 시작과 함께 유전자검사(NGS)**를 의뢰합니다.

위치	특징	흔한 수술
간내 담관암	간 안의 담관, 간 종양처럼 보임	간절제
간문부 담관암	간 입구의 담관 합류부	간절제 + 담관절제(큰 수술)
원위부 담관암	췌장 가까운 담관	췌십이지장절제술(휘플)
담낭암	쓸개	담낭 + 간 일부 + 림프절 절제
아직 미정	영상으로 위치 판단 중	추가 검사

내 위치: ☐간내 ☐간문부 ☐원위부 ☐담낭 ☐미정

오늘 물어볼 질문

1. 제 암은 어느 위치인가요?
2. 수술로 완전 절제가 가능한가요?
3. 황달이 있다면 배액은 언제, 어떤 방법으로 하나요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자

- 38°C 이상 발열·오한 + 황달·복통(담관염) → 해열제보다 먼저 연락, 밤이면 응급실
- 배액관이 빠지거나 배액이 갑자기 줄고 통증·발열, 관 주위로 많이 샘
- 배액에 피가 섞임, 피를 토하거나 검은 변(출혈)
- 외부배액량이 많은데 어지럽고 소변이 줄어듦(탈수)
- 의식이 흐려짐, 심한 복통
- 항암 중 38°C 이상 발열
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 담관염은 패혈증으로 빠르게 진행할 수 있어 즉시 치료가 필요합니다.
2. 배액관 문제는 담즙 정체와 감염을 일으킵니다.
3. 혈담즙·흑변·토혈은 출혈 신호입니다.
4. 외부배액은 수분·전해질 손실로 탈수를 일으킬 수 있습니다.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 영상 판독지와 위치 확인 ② 간담췌 전문 센터 예약 ③ 황달·배액 계획 확인.

오늘 할 일 (3개)

- □ CT·MRI(MRCP: 담관을 자세히 보는 MRI) 판독지, 위치 확인
- □ 간담췌외과·췌담도 내과가 함께 보는 센터 예약

- □ 황달이 있으면 배액 방법(내시경 담도 시술 ERCP / 피부를 통한 담도배액 PTBD)과 일정 확인 — 응급 담관염이 아니면 **배액 전에 고해상도 영상**을 먼저 찍는 것이 수술 계획에 도움이 될 수 있습니다

이번 주 할 일

- □ 흉부·복부(·골반) 다상 CT, MRI/MRCP, 필요 시 PET/CT
- □ 조직검사 또는 브러시 세포검사(**음성이어도 암이 배제되지 않을 수 있음**)
- □ 서류 확보: 병리보고서, 슬라이드·블록, 영상 CD, (담낭절제 후라면)
수술기록지
- □ 산정특례 신청(확진일로부터 30일 이내)

오늘 물어볼 질문

1. 수술 전 조직 확진이 꼭 필요한가요, 수술로 진단과 치료를 함께 하나요?
2. 배액이 필요하다면 어떤 스텐트를 넣나요?
3. 다음 치료는 어느 병원에서 받는 것이 좋을까요?

4장. 유연히 발견된 담낭암(담낭절제 후)

30초 요약: 담석 등으로 담낭을 뗐는데 병리에서 암이 나온 경우입니다. **병리 깊이**에 따라 추가 수술이 필요할 수 있습니다. "이미 수술했는데 또?"라는 마음은 자연스럽습니다. 추가 수술은 **남아 있을 수 있는 암을 찾아 완치 가능성을 높이기 위한 것**입니다.

**병리 깊이
(일반적)**

흔한 다음 단계

T1a(점막층), 대개 추적
절제면 음성

병리 깊이 (일반적)	흔한 다음 단계
T1b(근육층) 이상	간 일부(담낭이 붙어 있던 자리) + 림프절 절제 재수술 평가(T1b는 병원에 따라 추적을 권하기도 하니 이유를 물어보세요)
낭관 절제면 양성	담관 추가 절제 논의
수술 중 담즙 유출	복막 재발 위험 고려

- 재수술 전 병기 영상(CT·MRI)을 다시 찍습니다.
- **첫 수술 병원에서 슬라이드·블록·수술기록지**를 받아 간담체 전문 센터로 가세요.
- **산정특례 30일은 첫 병원 병리보고서의 확진일**부터 계산될 수 있습니다. 병원을 옮기기 전에 첫 병원 원무과에 신청 여부를 확인하세요(공단 확인 필요).

5장. 병리·검사

검사	목적
다상 CT(흉부·복부·골반)	종양·혈관·림프절·폐 전이
MRI·MRCP	담관 침범 범위
내시경 초음파·ERCP	조직 채취, 배액
CA19-9·CEA	추적 표지자(황달 시 높게 나올 수 있음)

 **완전판에서 이어집니다** — 수술 후 병리 기록, 판독지 단어장

6장. 유전자검사(NGS)

30초 요약: 담도암은 표적치료로 이어질 수 있는 유전자 변화가 비교적 많은 암입니다. 절제 불가·전이성이면 **1차 치료 시작과 함께 NGS를 의뢰**하세요. 수술한 환자도 재발 시 수술 검체로 검사할 수 있으니 **블록 보관 병원을** 확인해 두세요. 결과까지 보통 수주 걸립니다.

변화	주로 많은 곳	2차 이후 표적 범주(국내 허가·급여 확인 필요)
FGFR2 융합	간내 담관암	FGFR 억제제
IDH1 변이	간내 담관암	IDH1 억제제
HER2 과발현/증폭	담낭암·간외 담관암	HER2 이중특이항체·항체-약물접합체(ADC)·항HER2 병용
BRAF V600E	일부	BRAF + MEK 억제제
MSI-H/dMMR, TMB-H	드물	면역치료
NTRK·RET 융합	드물	해당 표적

- 대부분의 표적치료는 **1차 항암 + 면역치료 이후** 다음 치료로 검토됩니다. 순서는 담당 종양내과와 정합니다.
- 해외에서 허가된 표적약이라도 국내에서는 사용이 제한되거나 비급여인 경우가 있습니다(센터 2023년 자료 기준 FGFR2·IDH1 약). 변이가 나오면 국내 사용 가능 여부, 비용, 참여할 임상시험을 함께 물어보세요(최신 확인 필요).

결과 기록: FGFR2 _ · **IDH1** _ · HER2 _ · **BRAF** _ · MSI _ · **기타** _

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

7장. 담도배액

30초 요약: 황달은 간 기능을 떨어뜨리고 항암을 어렵게 하므로 배액이 먼저일 수 있습니다. **플라스틱 스텐트**는 막히기 쉬워 정기 교체가 필요할 수 있고, **금속 스텐트**는 오래 유지되지만 제거가 어려워 수술 가능성 평가 후 결정하는 경우가 많습니다.

내 스텐트·배액관: ☐플라스틱 ☐금속 ☐PTBD(외부/내외부) · 시술일 _ · 교체 예정

—

 **완전판에서 이어집니다** — 배액관 하루 관리 체크표와 '이럴 땐 바로 전화' 카드

8장. 수술과 보조치료

30초 요약: 완전 절제가 가능하면 수술이 치료의 핵심입니다. 간을 많이 떼야 하면 남은 간을 키우는 **문맥색전술**을 먼저 하기도 합니다. 수술 후에는 **보조항암(먹는 항암제 약 6개월 범위)**을 하고, 절제면 양성 등에서는 방사선을 상의합니다.

- 수술 후 간부전·합병증 위험과 예상 입원·회복 기간을 물어보세요.
- 보조항암 약은 국내에서 약마다 급여 여부가 다를 수 있습니다
(국가암지식정보센터 2023년 자료 기준: 먹는 약 카페시타빈은 비급여, 주사 5-FU/류코보린은 급여). 시작 전에 약 이름과 본인 부담을 확인하세요(최신 기준 확인 필요).

9장. 진행·전이성 담도암

30초 요약: 1차 전신치료는 **항암(젬시타빈 + 시스플라틴) + 면역치료(대표 예: 더발루맙·렘브롤리주맙)** 병용이 국제 표준 범주입니다(국내 허가·급여 확인 필요). 이후 유전자 결과에 따라 표적치료를 검토합니다. 수술이 어려운 국소 병변에는 방사선(정위체부방사선 등)을 검토할 수 있습니다.

- 가려움 때문에 잠을 못 자면 참지 말고 알려세요. 배액이 가장 중요한 치료이며 가려움약을 처방받을 수 있습니다.
- 면역치료를 더하면 급여 여부에 따라 본인 부담이 크게 달라질 수 있습니다(센터 2023년 자료에서는 병용 시 전체 비급여로 안내). 첫 주기 전에 현재 급여 기준과 예상 비용을 담당의·원무과에 물어보세요(확인 필요).

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법

PART 3. 30일 실행 로드맵

■ **완전판에서 이어집니다** — 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

먹는 것·가려움·간

30초 요약: 담즙이 잘 흐르지 않으면 기름진 음식 소화가 어렵고 가려움이 생깁니다. 배액이 잘 되는 것이 먼저이며, 소량씩 자주 먹고 체중을 기록하세요.

■ **완전판에서 이어집니다** — 식사 요령과 가려움 관리

추적

- 수술 후 처음 2년은 몇 개월 간격으로 CT·표지자를 확인하는 경우가 많습니다 (병원별 상이).
- 국내 자료로는 수술 후 3년까지 3~6개월마다, 5년까지 6개월마다, 그 뒤에는 해마다 외래 추적을 하는 방식이 흔히 소개됩니다. 피검사(간기능·CA19-9·CEA)와 흉부 사진·복부 CT를 함께 봅니다(병원별 상이).

■ **완전판에서 이어집니다** — 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

■ 완전판에서 이어집니다

- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
3. **제도는 바뀔니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

■ **완전판에서 이어집니다** — 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 **3개만** 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다. 1. 제 암의 위치는 어디인가요? 2. 완전 절제가 가능한가요? 3. 배액이 필요한가요? 스텐트 종류는요? 4. 조직 확진은 어떻게 하나요? 5. (담낭암) 추가 수술이 필요한가요? 6. 유전자검사(NGS)는 언제 의뢰하나요? 7. 1차 치료는 무엇인가요? 8. 수술 후 보조항암은 얼마 동안 하나요? 9. 바로 연락해야 할 증상은요? 10. 임상시험이 있나요?

내 담도암 한 장 요약

항목	내 기록
위치	간내 / 간문부 / 원위부 / 담낭 / 미정
병기	_____
절제 가능성	가능 / 경계 / 불가
배액	없음 / 스텐트(____) / PTBD
유전자	FGFR2 _ IDH1 _ HER2 _____
첫 치료	수술 / 항암 + 면역치료 / 기타
산정특례	☐ 신청 ☐ 완료

오늘 꼭 물을 3가지: ① 수술이 가능한가요? ② 배액 계획은? ③ 유전자검사는 언제?

■ 완전판에서 이어집니다

- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
- 담도암 용어사전
- 담도암 자주 묻는 질문 12
- 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)
- 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Biliary Tract Cancers, Version 1.2026. NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 담낭·담도암 정보, 대한체담도학회·한국간담췌외과학회 자료, 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 실지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **출처:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터 — 사실 확인에 참고한 자료(센터 문장·그림은 실지 않음). 더 자세한 암 정보와 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899(평일 9~18시).
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.
- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허

의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.

- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.

완전판에는 이런 내용이 더 있습니다

- 수술 후 병리 기록, 판독지 단어장
- 배액관 하루 관리 체크표와 '이럴 땐 바로 전화' 카드
- 치료 목표 대화법, 완화의료·호스피스 이용법, 사전연명의료의향서, 치료를 쉬는 선택
- 2차 소견 받는 법, 병원 선택 기준, 다학제 진료, 임상시험 찾는 법
- 30일 실행 로드맵(일자별 체크리스트)
- 식사 요령과 가려움 관리
- 치료 중 증상별 자가관리 표(메스꺼움·피로·입안 혈음·변비·설사·불면·탈모·피부·손발 저림)
- 고통 온도계, 불안을 다루는 5분 방법, 상담 연결 경로, '내 탓' 생각 다루기
- 보호자 역할 나누기, 아이에게 알리는 법, 보호자 휴가 제도, 보호자 자신의 돌봄
- 직장 병행 전략, 회사에 말하는 범위, 복귀 계획
- 치료 중 식사·운동 원칙과 피해야 할 것
- 산정특례 신청 절차, 의료비 지원제도, 실손·암보험 서류, 회사 서류 체크리스트
- 같은 진단을 받은 세 사람의 30일(가상 사례)
- 담도암 용어사전
- 담도암 자주 묻는 질문 12
- 진료실 대화법(15분 진료를 30분처럼), 검사 준비 카드(CT·MRI·PET·조직검사·내시경)

- 워크북: 진료 기록지, 7일 증상 일지, 약·보충제 목록, 연락처 카드, 30일 체크달력
-

ApuDa.app — 더 많은 암·질환 교육 콘텐츠와 업데이트 Instagram 구독자 무료 배포판 · 상업적 재배포 금지

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>